

Fecha Última Actualización: 19-01-2026 18:00:25

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Carolina Andrea Silva Cabrera
Edad : 42a 1m 0d
Dirección : Copiapo 0270, San Guillermo

Rut : 15.742.833-0
Fecha Nacto: 19/12/1983
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2519992
Sexo : Femenino
Teléfono : 985477675

N° Epicrisis
469298

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/01/2026 14:24

Días Estadía: 15

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 19/01/2026 18:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

DISNEA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

FI CASR (SU): 04/01/2026
FI UCI: 05/01/2026
FI UTIM: 17/01/2026
ALTA: 19/01/2026

Carolina Silva Cabrera
41 años
15742833-0
Contacto: 9 8547 7698

ANTECEDENTES:

- Mórbitos: neuromielitis óptica AQP4(+) desmielinizante (tto MTP, PLEXx5 + rituximab, en sept 2025 ultima dosis), VMI + TQT (decanulada 18.11.25), GTT (disfagia severa), sd sjogren.
- Medicamentos: atropina, ipratropio, spiriva, colirio atropina, Famotidina 50 mg, pregabalina 75mg/dia, sertralina 50 mg al dia, hidroxyclorequina 100 mg al dia.
- Quirúrgicos: Cirugía bariátrica 2020, sin suplementación adecuada, TQT y GTT, histerectomía 2023
- Hábitos: Tabaquismo 7 cigarrillos al día, suspendido. IPA 3. OH (-), drogas (-).
- Alergias: trimebutino (presentó prurito y aumento de volumen en lengua, que cedió con tratamiento), nifedipino
- GO: G2A02, 2 cesáreas, histerectomía, sin menstruación, mamografía + normales, ACO
- Social: vive con 2 hijos y esposo, conductora del transantiago, con licencia. Buena red de apoyo
- Antecedentes familiares: (+) madre HTA,

MOTIVO DE CONSULTA: Disnea

HISTORIA ACTUAL

Paciente con hospitalización reciente (03/08/25 - 19/11/25) por alteración neurológica y marcha inestable, con amplio estudio reumatológico y neurológico se realiza dg de neuromielitis óptica, recibe tto con MTP; rituximab (primeras dos dosis separadas x 1 mes) y plasmaféresis x5. Durante la hospitalización con requerimiento de VMI prolongada, se realiza TQT y GTT.

Fecha Epicrisis : 19/01/2026 18:00

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 19-01-2026 18:00:25

Página 2 de 3

Posteriormente con UDH, se logra destete de TQT.

Actualmente consultó por cuadro que inicia 04.01, caracterizado por filtración de gastrostomía + disnea/cansancio, sin dolor torácico. Refiere en domicilio con sat > 95%. Sin otra sintomatología respiratoria. A la anamnesis dirigida no refiere ningún cambio de alimentación, conducta de riesgo o contacto epidemiológico de importancia, tomando todos sus medicamentos.

Ingresa inestable HDM, con signos de aumento del trabajo respiratorio y en falla respiratoria aguda, por lo que se intuba y se conecta a VMI.

Se realiza AngioTAC en el SU con hallazgo de neumopatía multifocal, más condensante en lóbulos inferiores. GTT bien posicionada. Signos de nefritis médica.

Ingresa a UCI para continuar manejo

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

1.HDN: ingresa inestable, con signos clínicos de shock, requerimientos de DVA, noradrenalina hasta 0.4, por lo que inicia 2° DVA con vasopresina. Tras 24 hrs de reanimación se logra suspensión de vasopresina (06/01) y posterior suspensión de noradrenalina (07/01). Tras extubación (10/01) evoluciona con tendencia a la HTA, por lo que se agregan amlodipino y captopril. Actualmente estable, con PA en límite bajo por lo que se suspenden antiHTA.

2.Respiratorio: VMI en contexto de IRA secundaria a neumopatía multifocal, agente aislado neumococo. Inicialmente con gran deterioro del intercambio, requiere sedoanalgesia profunda y BNM con rocuronio por 24 hrs. Evoluciona favorablemente, se logra avanzar en weaning de forma precoz, PVE exitosa (10/01), siendo extubada el 10/01. Con apoyo inicial de CNAF, hasta el día 12/01. Desde entonces con requerimientos de oxígeno por naricera, adecuado intercambio, sin aumento del trabajo respiratorio. Por antecedentes de disfagia severa, se mantiene con rehabilitación multimodal y énfasis en manejo de secreciones. Se mantiene con aspiración autogestionada oral. Logra suspender requerimientos de oxígeno hace varios días, sin conflicto actual.

3.Infectología: Obs NIH en paciente inmunosuprimido (RTX). Ingresa con cuadro compatible con shock séptico, foco pulmonar. Se escala ATB para cobertura de cocáceas gram (+) identificadas precozmente en CAET, quedando con mero/Vanco. Tras identificación de agente como neumococo, se desescala a ampicilina-sulbactam, evolución adecuada, completa 10 días.

Además, presenta lesiones herpéticas peribucales a derecha, se toma muestra de PCR (+) para HSV 1. Desde el 13/01 con tto con aciclovir para completar 7 días.

4.Renal y medio interno: ingresa con AKI KDIGO2, contexto de sepsis, que recupera en forma precoz. Evoluciona con hipernatremia leve que se maneja con agua libre. Actualmente sin conflicto

5.Nutrición: Se ajusta nutrición enteral a Diben HP 1.5 para cumplimiento de metas nutricionales. Mantiene tiamina 400 mg QD.

6. Gastroenterología: antec. de disfagia severa, usuaria de GTT, en el ingreso se consulta por aparente filtración importante por contrabertura de ostoma, contenido de retención. En TAC se informa GTT bien posicionada, sin colecciones. Tras reevaluación por equipo de Cx, se reinicia aporte enteral x GTT, sin incidentes. Sin conflicto actual.

7.Psiquiátrico: una vez extubada, se agrega Trazodona para optimizar higiene del sueño.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

Shock séptico de foco pulmonar, tratado

·Neumonía multilobar x neumococo

AKI KDIGO II, resuelto

Desnutrición calórico proteica severa

·Trastorno de deglución, usuaria de GTT.

Insuficiencia respiratoria aguda, resuelta

·IOT 04-10/01

Antecedentes: Neuromielitis óptica AQP4(+) desmielinizante (tto MTP, PLEXx5 + rituximab, en sept 2025 última dosis), Dg Ago 25, VMI + TQT (decanulada 18.11.25), GTT (disfagia severa), Dd Sjögren.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en BCG, HDN estable, afebril, sin requerimientos de O2.

Epicrisis realizada por Dr Raimundo Bustos Knight

Epicrisis aprobada por Dr Felipe Clavero Espinoza

Fecha Epicrisis : 19/01/2026 18:00

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:09

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

Indicaciones al alta

Reposo relativo.

Régimen cero por boca.

Nutrición enteral por GTT - Fresubin HP 50cc/h (Ya tiene en su casa)

Hospitalización domiciliaria para seguimiento por Fonoaudiología y kinesiología motora y respiratoria (manejo de secreciones).

Aciclovir 400mg cada 8 horas por GTT por 2 días

Bromuro de ipratropio 2 puff cada 8 horas por AEC

Tiotropio 1 inhalación al día

Atropina 1% colirio 2 gotas cada 8 horas sublinguales

Sertralina 50mg en la mañana por GTT

Famotidina 40 mg al día por GTT

Hidroxyclorequina 100 mg al día por GTT

Pregabalina 75mg en la noche (21:00) por GTT

Trazodona 100mg en la noche (21:00) SOS por GTT

Mantener controles con neurología, reumatología y hematología en ambulatorio.

Acudir al servicio de urgencias en caso de síntomas de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

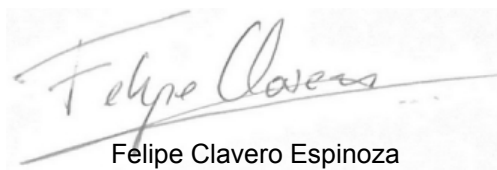
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Felipe Clavero Espinoza

Médico Tratante (Staff)